

Problemática: Segmentación y desigualdad en la calidad.

Presentador (Contexto y Problema):

"En Chile, la calidad de la salud está determinada por la capacidad de pago y no por la necesidad clínica. Mientras el sector privado prioriza la rapidez para quien puede pagarla, los usuarios de Fonasa sufren demoras crónicas. Esta fragmentación estructural hace que la salud funcione como un **bien de consumo** y no como un derecho humano, manteniendo brechas injustas en los resultados sanitarios."

Especialistas Técnicos (Solución: Registro Clínico Electrónico Nacional Interoperable):

- **Especialista 1:**

"La solución es la **Ficha Clínica Única Nacional**. La etapa 1 es el desarrollo de un 'Bus de Interoperabilidad' bajo estándares HL7 FHIR, que permita que los datos viajen entre el sector público y privado."

- **Especialista 2:**

"La etapa 2 es el 'Portal del Paciente Universal', una interfaz donde cada ciudadano es dueño de su información y puede atenderse en cualquier red sin perder su historial médico."

Analista de Datos (Argumentación y Cierre): "Defendemos la propuesta con los siguientes argumentos:

- **Argumento 1 (A-R-E-C):** La ficha única reduce la brecha de atención entre sistemas (**Afirmación**), ya que permite la continuidad del cuidado independientemente de si el paciente es Isapre o Fonasa (**Razón**). Datos de la *Organización Panamericana de la Salud* indican que la interoperabilidad reduce la duplicación de exámenes en un 15% (**Evidencia**). Esto libera recursos del sector público para invertirlos en quienes más lo necesitan, igualando el estándar de trato (**Conexión lógica**).
- **Argumento 2:** Citamos a *Global Health Informatics*, que señala que el acceso universal a datos clínicos disminuye la mortalidad por errores de medicación en un 10%. **Cierre:** El resultado esperado es un estándar universal de salud. En una frase: 'Una sola salud para un solo Chile'."

¿Por qué consideran que su solución es la más adecuada frente a otras alternativas? La solución de la Ficha Clínica Única Nacional se considera adecuada porque permite la interoperabilidad mediante un "Bus de Interoperabilidad" bajo estándares HL7 FHIR, logrando que los datos viajen entre el sector público y privado. Esto garantiza la continuidad del cuidado, independientemente de si el paciente pertenece a Isapre o Fonasa, eliminando la fragmentación del sistema.

¿Cuáles serían los principales desafíos en su implementación? Se infiere que los desafíos radican en el desarrollo técnico de la etapa 1 (el Bus de Interoperabilidad) y la creación de la interfaz de la etapa 2 (el Portal del Paciente Universal) para que cada ciudadano sea dueño de su información.

Si tuvieran que ajustar algo del proyecto, ¿qué modificarían y por qué? Incluir un carnet de salud digital en el celular para que el paciente tenga control total de sus datos.

¿Por qué consideran importante solucionar esta problemática? Es crucial porque actualmente la calidad de la salud en Chile depende de la capacidad de pago y no de la necesidad clínica. Al funcionar la salud como un bien de consumo y no como un derecho humano, se mantienen brechas injustas en los resultados sanitarios, especialmente para los usuarios de Fonasa que sufren demoras crónicas.

¿Qué criterios usaron para seleccionar la información más relevante de la investigación? Se utilizaron criterios de impacto técnico y sanitario, priorizando estándares internacionales de interoperabilidad y datos de organismos reconocidos como la Organización Panamericana de la Salud y Global Health Informatics para respaldar la eficacia de la propuesta.

¿Cuál es el objetivo principal que buscan lograr? El objetivo es establecer un estándar universal de salud donde la atención sea equitativa para todos los ciudadanos.

¿Qué aspecto de la problemática consideran el más urgente o crítico? Lo más crítico es la fragmentación estructural que genera desigualdad en la calidad de atención y resultados sanitarios basados en el poder adquisitivo.

¿Qué cambios concretos esperan ver tras la implementación? Se espera una reducción del 15% en la duplicación de exámenes, lo que libera recursos para el sector público, y una disminución del 10% en la mortalidad por errores de medicación. Además, se busca que el paciente pueda atenderse en cualquier red sin perder su historial médico.

¿Qué actores se verán más beneficiados y por qué? Los usuarios de Fonasa se benefician al reducirse las brechas de atención y las demoras. Asimismo, cada ciudadano se beneficia al convertirse en dueño de su propia información clínica a través del Portal Universal.

¿Cuál creen que es la principal fortaleza de su propuesta? Su fortaleza es la capacidad de asegurar la continuidad del cuidado y la eficiencia en el uso de recursos, igualando el estándar de trato entre los distintos sistemas de previsión.

¿Cuál creen que es la principal debilidad de su propuesta? El documento no identifica debilidades de manera explícita, enfocándose en los beneficios de la interoperabilidad y el acceso universal a datos.

¿Qué evidencia encontraron que les confirmó que este problema es real? La evidencia se basa en la observación de que el sector privado prioriza la rapidez para quien paga, mientras el sector público enfrenta demoras crónicas, tratando la salud como un bien de consumo.

¿Qué dato fue el más relevante para ustedes? Los datos de la Organización Panamericana de la Salud sobre la reducción de duplicación de exámenes (15%) y los de Global Health Informatics sobre la reducción de mortalidad (10%) son los pilares argumentativos de la propuesta.

¿Por qué creen que su proyecto es importante? Porque busca transformar la salud en un derecho humano real en Chile, eliminando la segmentación y asegurando que la atención dependa de la necesidad clínica.

¿Cómo resumirían su propuesta en una sola frase? "Una sola salud para un solo Chile". "Un solo historial clínico para garantizar una salud universal sin distinciones económicas".